第 七 章

生病了，去哪儿

> 「药不管用」不是原因，是算完账之后，说给自己听的理由。

发烧到 38 度，你从抽屉里翻出上个月剩的感冒药，吃了两片。

同桌说：别去，那儿的药不管用。

你问她去过吗。她说没有，都这么说。

你想了想，也是。

几乎每个班都发生过的对话

7.1 不去，是一笔算过的账

先把这件事说破：「药不管用」通常不是先去了解、再下的判断。它是决定已经做完之后，补上的一句解释。

真实的账是这样的。去一趟的成本是确定的：跟老师请假、下楼、排队、把哪儿难受说清楚、可能落掉一节课，有的学校还要通知家里。而收益是不确定的：你也不知道去了能不能好。

确定的成本，换一个不确定的收益。任何人算这笔账，答案都是不去。这跟勇敢不勇敢没关系，是账算得没错。

那「听说不管用」是怎么变成共识的？有个细节值得看：**说这话的人，多半没去过。**

而这条消息在传的时候，天生是偏的。去了、好了的人，不会特意回来说一句「其实有用」；去了、没立刻好的人，一定会说。你听到的样本，从源头就是斜的。

当然有一半是真的：医务室能给的多是对症的常用药，重的它处理不了，只能往外转。这点没冤枉它。但「吃了第二天没好」不等于药没用——感冒本来就要一周。药管的是难受，不管好得快。

所以真正的问题不在「该不该去」，在这笔账里有一项被漏掉了：**拖**。多数小毛病会自己好，但有一些不会。而拖过某个点，代价会从「一节课」跳到「一周」。

还有一项被低估了：医务室真正值钱的地方不是给药，是判断你到底要不要出去。这件事它比你有经验。

于是问题可以换个问法：不是「值不值得去」，是「这一次，是不是那种会自己好的」。

7.2 值得跑一趟的情况

外伤：扭伤、划伤、烫伤。

发烧：38.5 以上，或者低烧持续两天。

急性腹泻、呕吐。

过敏：起疹子、痒、局部肿。

任何疼到影响上课的疼痛。

这几类有共同点：要么当场就能处理，要么处理不了也得赶紧往外转。都属于「去了不亏」——而且都是「不会自己好」的那种。

7.3 去了怎么说

三句话，按这个顺序说：

1. **什么时候开始的**
   「前天晚上」「今天早自习」。

2. **什么感觉**
   「是胀，不是疼」「一阵一阵的」「按下去更疼」。形容得越具体，越省时间。

3. **有没有变重**
   「昨天还好，今天开始吐」。这一句决定了对方紧不紧张。

如果你记过——什么时候开始的、吃了什么、疼了多久——直接拿出来。它比「我难受」有用得多。

7.4 抽屉里该有什么

既然多数时候是自己扛，那手上有什么就很重要。一份最基本的清单：

对乙酰氨基酚

用来对付　发烧、头痛

注意　很多复方感冒药里已经有它，别叠加着吃

布洛芬

用来对付　痛经、头痛、牙痛

注意　别空腹吃；胃不好的饭后吃

蒙脱石散

用来对付　急性腹泻

注意　和其他药隔开两小时，它会吸附别人

口服补液盐

用来对付　腹泻、呕吐后补水

注意　别用运动饮料代替，糖和盐的比例不对

碘伏棉签、创可贴

用来对付　小伤口

注意　伤口脏要先冲洗，再消毒

体温计

用来对付　判断要不要报

注意　电子的就够，别凭手感猜

> **剂量这里一个都不给。**同一个药名，片剂和缓释胶囊的用法就不一样，年龄体重也影响用量——这种事只能看说明书或者问医生。这里能做的是告诉你「它大概是干什么的」，以及「什么时候别乱搭」。

另外：每年开学清一次抽屉，过期的扔掉。药过期不是「效果差点」，是有的会分解出不该有的东西。

7.5 红旗症状

比第一章那张更全。出现任何一条，不用再观察。

这九条，一条都不用过夜

- 大便发黑、像柏油，或者呕出血
- 肚子持续剧痛超过 6 小时，而且越来越重
- 发烧超过 39℃，或者发烧三天不退
- 明显脱水：口干、尿少、站起来发晕
- 呼吸困难、胸闷、心跳一直很快
- 意识模糊，叫不太应
- 剧烈头痛，伴呕吐或者脖子发硬
- 过敏时嘴唇、喉咙肿起来，喘不上气
- 伤口红肿热痛在扩散，或者有脓

这几条不代表一定很严重。但它们都过了「自己扛一扛」的界限，需要有人看一眼。

7.6 什么时候该请假

硬扛一节课，是意志问题。硬扛一天，是判断问题。

该请的情况：发烧、呕吐腹泻、疼到没法集中注意力、有传染性的（流感、诺如）。

最后一条值得多说一句：带病上课不是勤奋。它把一个班拖下水，也让你自己好得更慢——这一天的课没听进去，后面三天还得补。

能忍不算本事。忍到撑不住那天，落下的课更多。